

Model PTSD

Dlaczego objawy się utrzymują. Dwa uzupełniające się modele wyjaśniające: przetwarzanie emocjonalne (Foa) i model poznawczy (Ehlers & Clark). Razem dają mapę, na której widać, gdzie pracujesz.

CZAS: 20 min — przeczytanie Na początku pracy terapeutycznej

ŹRÓDŁO: Foa & Kozak (1986); Ehlers & Clark (2000)

JAK UŻYWAĆ

PTSD utrzymuje się dlatego, że **trauma nie została w pełni przetworzona** — wspomnienie pozostaje „aktywne”, a system unikania uniemożliwia jego integrację. Dwa kluczowe modele wyjaśniają to z różnych stron. **Foa & Kozak (1986)** opisali *strukturę strachu*: traumatyczne wspomnienie istnieje w pamięci jako sieć powiązanych elementów (bodźców, reakcji, znaczeń); aktywacja tej sieci wywołuje pełną reakcję traumatyczną. **Ehlers & Clark (2000)** dodali wymiar *poznawczy*: po traumie zmieniają się **przekonania** o sobie, świecie, przyszłości — a one same generują poczucie obecnego zagrożenia. Razem oba modele są fundamentem terapii.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Modele pomagają zrozumieć, że objawy **nie są przypadkowe ani „niezrozumiałe”** — wynikają z konkretnych mechanizmów, które można nazwać i zmienić. *Jeśli wspomnienie traumatyczne istnieje jak nieaktywne archiwum z aktywnym przyciskiem alarmu*, terapia polega na: **1)** celowym otwieraniu tego archiwum w kontrolowanych warunkach, **2)** aktualizacji znaczeń (przekonań), **3)** integracji wspomnienia z resztą biografii. Foa i wsp. (2007) w meta-analizie 65 badań wykazali, że terapia oparta na tym modelu (przedłużona ekspozycja, ang. *prolonged exposure*) redukuje objawy PTSD o **rozmiar efektu d ≈ 1,1** — to bardzo duży efekt kliniczny.

01 Model przetwarzania emocjonalnego (Foa & Kozak 1986)

Trauma tworzy w pamięci **strukturę strachu** — sieć trzech rodzajów elementów. Aktywacja jednego pociąga za sobą resztę. Stąd intensywność i pełnoobjawowość reakcji na nawet drobne przypomnienia.

1 · BODŹCE

co wtedy było

Zapachy, dźwięki, widoki, dotyk, miejsca, osoby, ubrania, czas dnia. Wszystkie elementy zmysłowe obecne w czasie traumy. Mogą być pojedyncze albo połączone. W pamięci pozostają „surowe”, nieprzetworzone.

2 · REAKCJE

co wtedy ciało zrobiło

Fizjologia: tętno, oddech, napięcie, zamrożenie, gorąco/chłód. Emocje: lęk, gniew, bezradność, wstyd. Zachowania: walka, ucieczka, zamrożenie. Cała kaskada zostaje „zapisana” razem z bodźcami.

3 · ZNACZENIA

co to znaczyło

„Umrę”, „to moja wina”, „świat jest niebezpieczny”, „nikomu nie można ufać”, „nigdy nie będę bezpieczny/-a”. Te znaczenia wyciągnięte w chwili traumy *uogólniają się* na całe życie po niej.

Mechanizm utrzymania: wystarczy aktywacja *jednego* elementu (zapach, dźwięk), żeby uruchomić **całą sieć** — pełną reakcję traumatyczną z fizjologią i znaczeniami. Stąd flashbacki na bodźce niepowiązane z aktualnym zagrożeniem. Cel terapii: *aktywować sieć w bezpiecznym kontekście tak długo*, by zintegrowała się z informacją „to było, teraz jest bezpiecznie”.

02 Model poznawczy (Ehlers & Clark 2000)

PTSD utrzymuje się, bo osoba **doświadcza obecnego, ciągłego zagrożenia** — mimo że trauma minęła. Trzy mechanizmy podtrzymujące:

1 • SPECYFICZNE WŁAŚCIWOŚCI PAMIĘCI TRAUMATYCZNEJ

Wspomnienie traumy nie jest zintegrowane w czasie i kontekście. Brakuje informacji „*to było wtedy, teraz jest inaczej*”. Stąd intruzje przeżywane jak teraźniejszość, brak rozdzielenia „wtedy/teraz”.

2 • ZMIENIONE PRZEKONANIA (INTERPRETACJE)

O sobie: „jestem winny/-a”, „jestem słaby/-a”, „nie zasługuję”. **O świecie:** „wszędzie czyha niebezpieczeństwo”, „nikomu nie można ufać”. **O traumie:** „mogłem/-am temu zapobiec”. Te interpretacje *generują obecne zagrożenie*, niezależnie od traumy.

3 • STRATEGIE PODTRZYMUJĄCE

Unikanie myśli o traumie, ruminacja, alkohol/substancje, kompulsywna czujność, próby kontroli. Te strategie *krótkoterminowo* obniżają lęk, ale **długoterminowo** uniemożliwiają przetworzenie traumy. To kluczowy mechanizm utrzymujący PTSD.

03 Co z tego wynika dla terapii

Z MODELU FOI → EKSPOZYCJA

Kontrolowana, powtarzana *aktywacja struktury strachu* w bezpiecznym kontekście. Stopniowo do wspomnienia dołącza nowa informacja: „nic się nie dzieje”. To redukuje siłę reakcji. **Cel:** trauma przetworzona, zintegrowana, dostępna jak inne wspomnienia.

Z MODELU EHLERS/CLARK → PRACA Z PRZEKONANIAMI

Identyfikacja konkretnych *punktów utknięcia* (przekonań blokujących), dowodów za i przeciw, alternatywnych interpretacji. **Cel:** aktualizacja interpretacji „wtedy” w świetle „teraz” — często wsparta dowodami nieobecnymi w chwili traumy.

Klucz: oba modele są *zgodne i komplementarne*. Współczesne protokoły terapii PTSD (PE, CPT, EMDR) łączą elementy obu — pracują z **wspomnieniem** (Foa) i z **przekonaniami** (Ehlers/Clark). W meta-analizie Bisson i wsp. (2013, Cochrane) takie terapie traumie-skoncentrowane miały **NNT około 3** (na 3 leczone osoby 1 osiąga remisję, która bez terapii by nie wystąpiła). To bardzo silny efekt jak na zaburzenie psychiczne. PTSD jest leczalne — nawet po wielu latach od traumy.